BONUS 3

Verslag per klinische vraag: 30 klinische vragen

Welke vraag er ook op de aanvraag staat, de eerste zin van je verslag moet die vraag beantwoorden. Voor de 30 meest voorkomende klinische vragen: wat het verslag beslist moet beantwoorden, de negatieve zin en de positieve zin.

Inhoud

Waarom de klinische vraag voorop staat

Neuroradiologie — 5 vragen

Thorax — 7 vragen

Abdomen en pelvis — 10 vragen

Vasculair — 3 vragen

Musculoskeletaal en wervelkolom — 5 vragen

Volgende stap

AAN DE SLAG

Waarom de klinische vraag voorop staat

In de stap VOORBEREIDEN lees je de aanvraag; in de stap SAMENVATTEN beantwoord je die.

> *Als de aanvragende arts het verslag opent, zoekt hij maar één ding: het antwoord op zijn vraag. Vindt hij dat niet, dan belt hij of interpreteert hij het verslag verkeerd.*

1. **Lees de aanvraag en breng de vraag terug tot één woord** — «appendicitis?», «bloeding?», «steen?».
2. **Doorloop toch volledig** — de vraag geeft focus, maar de andere gebieden worden niet overgeslagen.
3. **Beantwoord de «beslist»-lijst van de vraag in de Bevindingen** — elk punt wordt als positieve of als relevante negatieve bevinding opgeschreven.
4. **De eerste zin van de Conclusie is het antwoord op de vraag** — indien positief de bevinding en zo nodig melding; indien negatief een duidelijke negatieve zin.
5. **Vermeld de beperking** — vermeld het expliciet als het onderzoek ontoereikend is om de vraag uit te sluiten.

Als de aanvraag vaag is

Probeer bij vage aanvragen zoals «controle» of «pijn» de klinische informatie uit het dossier of van de aanvragende arts te achterhalen. Lukt dat niet, structureer het verslag dan naar de meest waarschijnlijke vraag en beantwoord de veelvoorkomende oorzaken één voor één.

DEEL 1

Neuroradiologie

5 klinische vragen

01 «Beroerte?»

Veelgebruikt onderzoek: CT hersenen zonder contrast ± CT-angiografie; MRI-DWI

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er wel of geen bloeding (eerste zin)
- Tekenen van vroege ischemie en vaatgebied
- Hyperdense-arterieteken
- Als er CT-angiografie is gedaan: occlusie van een groot vat
- Tijdstip van melding

NEGATIEVE ZIN

Geen intracraniële bloeding vastgesteld. Geen vroege ischemische veranderingen gezien; een vroeg ischemisch herseninfarct is op blanco CT mogelijk niet zichtbaar.

POSITIEVE ZIN

Geen intracraniële bloeding; [rechts/links] Tekenen van vroege acute ischemie in het stroomgebied van de ACM. In het kader van het strokeprotocol [uur] gemeld.

02 «Hoofdtrauma — bloeding?»

Veelgebruikt onderzoek: CT hersenen zonder contrast (hersen- en botvenster)

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Extra-axiale en parenchymateuze bloeding
- Massa-effect en midline shift (mm)
- Basale cisternen
- Fractuur van calvarium en schedelbasis
- Pneumocefalus

NEGATIEVE ZIN

Geen acute intracraniële bloeding, massa-effect of calvariumfractuur vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] acute [epiduraal/subduraal] hematoom; [.. mm] middenlijnverschuiving. [Tijdstip] gemeld.

03 «Plotse hevige hoofdpijn — SAB?»

Veelgebruikt onderzoek: CT hersenen zonder contrast ± CT-angiografie

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Subarachnoïdale bloeding en de verdeling ervan
- Hydrocefalus
- Intraventriculaire of parenchymateuze bloeding
- CTA-advies voor aneurysma

NEGATIEVE ZIN

Geen subarachnoïdale bloeding vastgesteld. De sensitiviteit van CT neemt af naarmate er meer tijd sinds het begin is verstreken; bij aanhoudende klinische verdenking wordt verdere evaluatie aan het klinisch oordeel overgelaten.

POSITIEVE ZIN

[In de basale cisternen] subarachnoïdale bloeding; hydrocefalus [afwezig/aanwezig]. CT-angiografie aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.

04 «Massa?»

Veelgebruikt onderzoek: MRI van de hersenen met contrast (bij twijfel op CT)

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Aantal, plaats en grootte van de laesies
- Onderscheid intra-/extra-axiaal
- Oedeem en massa-effect
- Herniatie
- Meest waarschijnlijke differentiaaldiagnose

NEGATIEVE ZIN

Op MRI van de hersenen met contrast geen massalaesie of pathologische aankleuring vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] [kwab]: [.. mm] [intra-axiaal/extra-axiaal] massa; [differentiaaldiagnose]. Tekenen van herniatie [afwezig/aanwezig].

05 «Hydrocefalus / shuntdisfunctie?»

Veelgebruikt onderzoek: CT hersenen zonder contrast; vergelijking met het vorige onderzoek

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Verandering van de ventrikelgrootte ten opzichte van het vorige onderzoek
- Periventriculair oedeem
- Positie van de tip van de shuntkatheter
- Bloeding

NEGATIEVE ZIN

Geen verandering van de ventrikelgrootte ten opzichte van het vorige onderzoek; tip van de shuntkatheter [locatie].

POSITIEVE ZIN

Duidelijke verwijding van de ventrikels ten opzichte van het vorige onderzoek; kan passen bij shuntdisfunctie. [Tijdstip] gemeld.

DEEL 2

Thorax

7 klinische vragen

06 «Pneumothorax?»

Veelgebruikt onderzoek: Thoraxfoto; zo nodig CT of POCUS

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er een pneumothorax, zijde
- Maat of hoeveelheid
- Aanwijzing voor spanning
- Bijkomende ribfractuur, subcutaan emfyseem

NEGATIEVE ZIN

Geen pneumothorax vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] pneumothorax, apicaal [.. mm]; tekenen van spanning [afwezig/aanwezig]. [Tijdstip] gemeld.

07 «Pneumonie?»

Veelgebruikt onderzoek: Thoraxfoto; zo nodig CT thorax

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er consolidatie, kwab/segment
- Pleuravocht
- Cavitatie of abces
- Verandering ten opzichte van het vorige onderzoek

NEGATIEVE ZIN

In het longparenchym geen consolidatie die op pneumonie wijst.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] [kwab] consolidatie; kan in samenhang met de kliniek passen bij pneumonie. Pleuravocht [afwezig/aanwezig].

08 «Longembolie?»

Veelgebruikt onderzoek: CT-pulmonalisangiografie

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Toereikendheid van de opacificatie
- Is er embolie en het meest proximale niveau
- Rechterventrikelbelasting
- Alternatieve diagnose (pneumonie, effusie)

NEGATIEVE ZIN

Opacificatie van de arteria pulmonalis toereikend; geen longembolie vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

[Bilateraal] [lobair/segmentaal] acute longembolie; rechterventrikelbelasting [afwezig/aanwezig]. [Tijdstip] gemeld.

09 «Aortadissectie?»

Veelgebruikt onderzoek: CT-angiografie (blanco + arteriële fase)

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er een dissectie
- Betrokkenheid van de aorta ascendens
- Betrokkenheid van zijtakken en orgaanperfusie
- Pericardeffusie, mediastinaal hematoom
- Intramuraal hematoom

NEGATIEVE ZIN

Geen aortadissectie, intramuraal hematoom of penetrerend ulcus vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

[Stanford A/B] aortadissectie; [betrokkenheid van zijtakken]. Kritieke bevinding; [uur] gemeld.

10 «Positie van tube / katheter?»

Veelgebruikt onderzoek: Bedside AP-thoraxfoto

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Waar ligt de tip van elk device
- Afstand van de ETT tot de carina
- Of de maagsonde in de maag ligt
- Pneumothorax door de ingreep

NEGATIEVE ZIN

ETT-tip boven de carina [.. cm] boven, tip van de maagsonde geprojecteerd over de maag, tip van de CVK geprojecteerd over de vena cava superior; geen pneumothorax.

POSITIEVE ZIN

[Tip van de maagsonde geprojecteerd over de rechter hoofdbronchus], niet in de juiste positie. Vóór gebruik [uur] gemeld.

11 «Hartfalen / longoedeem?»

Veelgebruikt onderzoek: Thoraxfoto; echo van de longen

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Hartgrootte (met vermelding van de projectie)
- Vasculaire congestie en interstitieel oedeem
- Pleuravocht
- Verandering ten opzichte van het vorige onderzoek

NEGATIEVE ZIN
Geen aanwijzingen voor longoedeem of pleuravocht vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
Aanwijzingen voor longoedeem en bilateraal een geringe hoeveelheid pleuravocht; ten opzichte van het vorige onderzoek [toename/afname].

12 «Pleuravocht?»

Veelgebruikt onderzoek: Thoraxfoto; echo thorax

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er effusie, zijde
- Hoeveelheid
- Inhoud (echo: anechogeen, met septa, echogeen)
- Onderliggende parenchympathologie
- Geschikt venster voor interventie (indien gevraagd)

NEGATIEVE ZIN
Geen pleuravocht vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
[Rechts/Links] [weinig/matig/veel] hoeveelheid [anechogeen/gecompliceerd van aspect] pleuravocht.

DEEL 3

Abdomen en pelvis

10 klinische vragen

13 «Appendicitis?»

Veelgebruikt onderzoek: Kind/jongere/zwangere: echo; volwassene: CT met contrast

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is de appendix gezien
- Diameter, wand, omliggend vetweefsel
- Appendicoliet
- Perforatie, abces
- Als de appendix niet gezien is: dat dit appendicitis niet uitsluit

NEGATIEVE ZIN
De appendix is normaal van aspect; geen aanwijzingen voor acute appendicitis.

POSITIEVE ZIN
Bevindingen passend bij acute appendicitis; perforatie of abces [afwezig/aanwezig]. [Tijdstip] gemeld.

14 «Steen? (niersteenkoliek)»

Veelgebruikt onderzoek: CT zonder contrast (steenprotocol); echo

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er een steen, locatie en grootte (mm)
- Graad van hydronefrose
- Contralaterale nier
- Alternatieve diagnose

NEGATIEVE ZIN
Geen stenen of hydronefrose in de urinewegen vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
[Rechts/Links] [distaal] in de ureter [.. mm] steen en [licht] hydro-ureteronefrose.

15 «Cholecystitis?»

Veelgebruikt onderzoek: Echo abdomen

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Steen
- Wanddikte en pericholecystitisch vocht
- Sonografisch Murphy-teken
- Diameter van de ductus choledochus
- Complicatie (gangreen, perforatie)

NEGATIEVE ZIN
Galblaas normaal; geen stenen of tekenen van acute cholecystitis vastgesteld. Ductus choledochus [.. mm].

POSITIEVE ZIN
Bevindingen passend bij acute calculeuze cholecystitis; ductus choledochus [.. mm]. [Tijdstip] gemeld.

16 «Obstructie / ileus?»

Veelgebruikt onderzoek: Staande buikoverzichtsfoto; CT abdomen met contrast

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er obstructie, dunne/dikke darm
- Overgangszone en mogelijke oorzaak
- Tekenen van strangulatie/ischemie
- Vrije lucht

NEGATIEVE ZIN
Geen aanwijzingen voor mechanische darmobstructie.

POSITIEVE ZIN
[Regio] mechanische dunnedarmobstructie met een overgangszone ter hoogte van; tekenen van ischemie [afwezig/aanwezig].

17 «Perforatie / vrije lucht?»

Veelgebruikt onderzoek: Staande thoraxfoto; CT abdomen

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er vrije lucht
- Mogelijke plaats van perforatie
- Vrij vocht, abces
- Recente chirurgische voorgeschiedenis

NEGATIEVE ZIN
Geen vrije lucht vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
Pneumoperitoneum; [mogelijke lokalisatie] passend bij perforatie. [Tijdstip] gemeld.

18 «Pancreatitis / complicatie?»

Veelgebruikt onderzoek: CT abdomen met contrast (meestal enige tijd na het begin)

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Type pancreatitis (oedemateus/necrotiserend)
- Peripancreatisch vocht of collectie
- Vasculaire complicatie
- Galsteen

NEGATIEVE ZIN
Geen aanwijzingen voor acute pancreatitis.

POSITIEVE ZIN
Acuut [necrotiserend] pancreatitis; [collectie/vasculaire complicatie] [afwezig/aanwezig].

19 «Trauma — letsel van solide organen?»

Veelgebruikt onderzoek: Trauma-CT met contrast; FAST

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Elk solide orgaan afzonderlijk
- Hemoperitoneum en hoeveelheid
- Actieve extravasatie
- Darm-/mesenteriaal letsel
- Botletsels

NEGATIEVE ZIN
Geen aanwijzingen voor letsel van solide organen, vrij vocht of actieve bloeding vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
[Orgaan] letsel en hemoperitoneum; actieve extravasatie [afwezig/aanwezig]. [Tijdstip] gemeld.

20 «Extra-uteriene zwangerschap?»

Veelgebruikt onderzoek: Transvaginale en transabdominale echo van het bekken

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er een intra-uteriene zwangerschap
- Adnexmassa
- Vrij vocht en de inhoud ervan
- Toestand van de ovaria

NEGATIEVE ZIN
In de baarmoederholte [met dooierzak] vruchtzak gezien; geen adnexmassa of vrij vocht vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
Geen intra-uteriene graviditeit; [rechts/links] adnexmassa en vrij vocht, passend bij een extra-uteriene zwangerschap. [Tijdstip] gemeld.

21 «Diverticulitis?»

Veelgebruikt onderzoek: CT abdomen-pelvis met contrast

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Aangedaan segment
- Is het gecompliceerd (abces, perforatie, fistel)
- Grootte van het abces
- Alternatieve diagnose

NEGATIEVE ZIN
Geen aanwijzingen voor diverticulitis.

POSITIEVE ZIN
[Sigmoïd] in het colon acute [gecompliceerd/ongecompliceerd] diverticulitis; abces [afwezig/aanwezig, .. mm].

22 «Buikpijn — oorzaak?»

Veelgebruikt onderzoek: CT abdomen-pelvis met contrast of echo

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er acute chirurgische pathologie
- Veelvoorkomende oorzaken één voor één: appendix, galblaas, darm, urinewegen
- Vrij vocht en vrije lucht
- Vasculaire pathologie (aorta)

NEGATIEVE ZIN
Geen acute pathologie vastgesteld die de buikpijn verklaart.

POSITIEVE ZIN
[Bevinding]; kan de buikpijn verklaren. [Zo nodig melding].

DEEL 4

Vasculair

3 klinische vragen

23 «DVT?»

Veelgebruikt onderzoek: Veneuze Doppler-echo van de onderste extremiteit

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Welke segmenten zijn beoordeeld
- Comprimeerbaarheid
- Proximale grens van de trombus
- Zijn de kuitvenen beoordeeld

NEGATIEVE ZIN

[Rechts/Links] in de diepe venen van de onderste extremiteit [in de beoordeelde segmenten] geen trombose vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] [femoropopliteaal] segment acute DVT; proximale grens [niveau]. [Tijdstip] gemeld.

24 «Testistorsie?»

Veelgebruikt onderzoek: Scrotale grijswaarden- en kleurendoppler-echo

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Intratesticulaire flow (in vergelijking met de andere zijde)
- Grootte en echostructuur van de testis
- Funiculus spermaticus
- Alternatieve diagnose (epididymitis)

NEGATIEVE ZIN

Testiculaire flow beiderzijds symmetrisch; geen aanwijzingen voor torsie. Aanwezigheid van flow sluit intermitterende torsie niet volledig uit.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] geen flow in de testis gezien; passend bij torsie. Spoedbevinding; [uur] gemeld.

25 «AAA / ruptuur?»

Veelgebruikt onderzoek: Echo aorta abdominalis; CT-angiografie

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Maximale diameter (mm)
- Relatie tot de nierarteriën
- Periaortaal hematoom (ruptuur)
- Beperking van echo bij een symptomatische patiënt

NEGATIEVE ZIN

Aorta abdominalis van normale diameter; geen aneurysma vastgesteld.

POSITIEVE ZIN

Infrarenaal AAA, maximale diameter **[.. mm]**; tekenen van ruptuur **[afwezig/aanwezig]**. **[Tijdstip]** gemeld.

HOOFDSTUK 5

Musculoskeletaal en wervelkolom

5 klinische vragen

26 «Fractuur?»

Veelgebruikt onderzoek: Röntgenfoto (minstens twee projecties); zo nodig CT/MRI

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er een fractuur, welk bot en welk niveau
- Intra-articulaire uitbreiding
- Dislocatie, angulatie
- Luxatie
- Als de röntgenfoto negatief is: kans op een occulte fractuur

NEGATIEVE ZIN

Geen acute fractuur of luxatie vastgesteld. Als de klinische verdenking blijft, sluit een röntgenfoto een occulte fractuur niet uit.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] [bot] [lokalisatie] fractuur; [intra-articulair/extra-articulair], [dislocatie].

27 «Heupfractuur? (oudere, val)»

Veelgebruikt onderzoek: Bekken AP + heup lateraal; indien negatief MRI of CT

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Femurhals en intertrochantaire regio
- Dislocatie
- Bekkenring en rami pubis
- Advies voor aanvullend onderzoek naar een occulte fractuur

NEGATIEVE ZIN

Geen acute fractuur in heup en bekken vastgesteld. Bij hoge klinische verdenking MRI of CT aanbevolen met het oog op een occulte fractuur.

POSITIEVE ZIN

[Rechts/Links] femurhalsfractuur ([gedisloceerd/niet-gedisloceerd]).

28 «Myelumcompressie / cauda equina?»

Veelgebruikt onderzoek: MRI van de gehele wervelkolom of lumbaal

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Is er compressie, niveau en oorzaak
- Signaalverandering in het myelum
- Wortels van de cauda equina
- Bijkomende niveaus

NEGATIEVE ZIN
Geen compressie van het myelum of de cauda equina vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
[Niveau] ter hoogte van [oorzaak] met compressie van het myelum. Spoedbevinding; [uur] gemeld.

29 «Cervicaal trauma — fractuur?»

Veelgebruikt onderzoek: CT cervicale wervelkolom

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Stand
- Tekenen van fractuur en instabiliteit
- Craniocervicale overgang
- Prevertebrale weke delen
- Noodzaak van MRI voor ligamentair letsel

NEGATIEVE ZIN
Geen acute fractuur of standafwijking van de cervicale wervels vastgesteld.

POSITIEVE ZIN
[Niveau] ter hoogte van [fractuur/luxatie]; met het oog op instabiliteit [uur] gemeld.

30 «Septische artritis / osteomyelitis?»

Veelgebruikt onderzoek: Röntgenfoto; echo (effusie); MRI

HET VERSLAG MOET BESLIST BEANTWOORDEN

- Gewrichtseffusie
- Beenmergbetrokkenheid
- Weke-delenabces
- Beperking van de beeldvorming (de noodzaak van aspiratie is een klinische beslissing)

NEGATIEVE ZIN
[Gewricht]: geen effusie vastgesteld; geen beenmergveranderingen passend bij osteomyelitis.

POSITIEVE ZIN
[Gewricht]: effusie en [beenmergoedeem/abces]; spoedige klinische beoordeling met het oog op septische artritis/osteomyelitis aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu de Snelle bonus · Checklist voor het verslag op één pagina. Antwoord op de klinische vraag, zijde, maat, vergelijking en melding: controleer het in één minuut vóór ondertekening.

Voor volledige verslagsjablonen **Hoofdmateriaal · 120 kant-en-klare verslagsjablonen** kun je terugkeren.